

NS 22231567745 / 430

ELISABETE CARVALHO DA SILVA TROMBINI

IDADE: 74 PESO: 78 ALTURA: 155 PROFISSÃO: Aposentada - Empres.
 SINTOMAS: Causaço / mau humor / Refluxo / Dor cervical
 QUEIXAS: com tontura indisp. ao levantar.

MEDICAMENTOS: Hemifumarato de Quetiapina / Zolof
 Prebital pregabalina - HAS / DM / Depressão

MÉDICO: Dra Maria Cécilia (Triplixam / Plavix / Xigduo X2)

EXERCÍCIO FÍSICO: Caminhada (3x semana)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: — JANTAR: (18h)

HORA QUE DORME: 22/23 HORA QUE ACORDA: 7hr

COCHILLO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 41.7 SPO2: 86%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: N.

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA não

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS labirintite

(Concentração ↓) / Hipotireoidismo

12/06/23 Iniciou

19/06/23 P = 8.3 cmH₂O

IAH = 1.5 e/h

m. de uso: 7hr

fua claudia

05/07/23 P = 9 cmH₂O

m. de uso: 4h50'

IAH = 1.2 e/h

Fuga = 25.8 l/min.

Ana claudia

11/07/23 P = 7.7 cmH₂O

m. de uso: 5h13'

IAH = 0.6 e/h

fuga = 13.5 l/min.

Bem adaptado
fechou o nariz
5-8.

fua

31/07/23 P = 7.3 cmH₂O P95: 7.9 cmH₂O

IAH = 0.7 e/h

m. de uso: 6h27min

fuga = 29.2 l/min

25/08/23 P = 7.4 cmH₂O

IAH = 0.7 e/h

m. de uso 6h12'

fuga 30.4 l/min

Auto 5-8 / P95: 7.9 cmH₂O

* como penas fixa *

21/09 P = 7.6 cmH₂O

Fuga = 20 l/min

23

IAH = 0.6 e/h

m. de uso: 6hr

fua

Comprou CPAP Banco 510

04/02/20 - Retirando a uso do CPAP pois
foi a Geriatria e a mesma solicitou
Esta tendo quedas e perda de memória
recente
Pfixa: 7,0 Rampa 5 mi Pimicial 5

Natacha

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: > ALMOÇO: > LANCHE: - JANTAR: >

HORA QUE DORME: 22/23 HORA QUE ACORDA: 7/8

COCHILHO () SIM () NÃO () DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO () X NA SEMANA NÃO

FUMO () SIM () NÃO () X NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: Y () X () BANHEIRO: 3 X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 30 X

OVERLAP: 4/5 MALAMAR: 1/2 IAH: 1/2 SPO2: 80 X

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: 1/2

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

Concentração 7/8

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

12/02/20

Nome: ELISABETE CARVALHO DA SILVA TROMBINI

Data de Nascimento: 26-6-1949

IMC: 32,88

Sexo: Feminino

Data do exame: 15-05-2023

Peso: 79 kg

Altura: 1,55 m

Médico: DRA. MARIA CECILIA MMENEZES

PIRES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-05-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 550,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,5 e 167,0 minutos. O tempo total de sono foi de 494,5 min, eficiência de 89,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 64,8%; estágio N3: 14,8%; sono REM: 18,6%. O índice de despertares foi de 30,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 41,7/hora, sendo 25 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 270 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 86%, permanecendo 1,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 73 bpm e NREM de 55 - 80 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 41,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=86%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

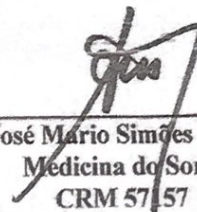
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Dra. Maria Cecilia Pires

**Geriatria
CRM 73043**

Elisete Canales J. Trombini

Solicito

Uso de CRAP para

Avaliação do caso - ajuste

permanência e acompanhamento

feita

05
06
2023

Dra. Maria Cecilia Pires
Geriatria
CRM 73043

Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 - Sala 208
Jd. Aquarius - São José dos Campos - SP - CEP 12246-000
Tel.: (12) 3943-5562 / ☎ (12) 99700-0534